

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5072290-16.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
RECORRENTE: MIGUEL ANAEL DA SILVA MARTINS DO NASCIMENTO
RECORRENTE: GLEICE APARECIDA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

PROCESSO CIVIL E SAÚDE - MEDICAMENTO NÃO INCORPORADORA AO SUS - LIRAGLUTIDA 6MG/ML (SAXENDA®) E AO INSUMO AGULHA 4MM (NOVOFINE®) - AUTOR QUE FAZ USO DE MEDICAMENTO METFORMINA FORNECIDO PELO SUS SEM SUCESSO - RISCO DE PERDA DE ÓRGÃOS - LIMITAÇÃO DO VALOR DA MEDICAÇÃO ÀQUELE INDICADO PELO NAT - AGRAVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - MEDIDA CONCEDIDA COM RESTRIÇÕES.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO da DPU e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO, de modo que a concessão da medida determinada na decisão do Evento 11 destes autos esteja condicionada aos limites orçamentários destacados pelo NAT (a Liraglutida 6mg/mL (Saxenda®) solução injetável com 1 cartucho 3mL possui o menor preço de venda ao governo de R\$ 212,60). Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2024.

5072290-16.2024.4.02.5101

510014629178 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5072290-16.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
RECORRENTE: MIGUEL ANAEL DA SILVA MARTINS DO NASCIMENTO
RECORRENTE: GLEICE APARECIDA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

A presente **MEDIDA DE URGÊNCIA** foi interposta pelo **Autor**, buscando a reforma da decisão proferida pelo Juizado Especial Federal de origem que indeferiu pedido de antecipação de tutela dos medicamentos indicados na inicial, nos seguintes termos:

"(...) Diante dos elementos instrutórios até aqui presentes, em sede de cognição sumária, não vislumbro o perigo de demora que justifique a tutela de urgência.

*No formulário preenchido pela médica assistente, **no que tange à necessidade do tratamento, foi consignado que a medida não é urgente nem imprescindível** (ev. 1, anexo2, fl. 13), de forma que eventual comprometimento grave do bem-estar não é imediato.*

Conforme ponderado acima, sobre os requisitos para o fornecimento de fármacos não incorporados ao SUS, definidos no âmbito do REsp nº 1.657.156/RJ, é imperiosa a comprovação "da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento", o que não se constata no presente caso.

Em complemento, o NAT atesta que, de acordo com diretriz da Sociedade Brasileira de Obesidade, o tratamento à doença é complexo e multidisciplinar, não existindo medida farmacológica em longo prazo que não envolva mudança de estilo de vida (MEV), como dieta e atividade física, o que não foi especificado satisfatoriamente na documentação constante dos autos.

Ademais, a médica assistente ressalta que o autor já faz uso de Meftormina para controle dos sintomas provocados pela diabetes.

Nesses termos, por ora, **INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA**, sem prejuízo de nova análise à vista de outros documentos que alterem a percepção das condições fáticas do caso, mormente acerca da urgência e imprescindibilidade do tratamento requerido. (...)

Foi relatado na inicial da medida de urgência que o Autor é acompanhada pelo Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, com **diagnóstico principal de Diabetes Mellitus tipo 2**, conforme laudo de 12/07/2024.

Consignou-se ainda que **o paciente apresenta obesidade grave, esteatose hepática, transtorno do espectro autista e déficit intelectual**. Neste sentido, relata o referido laudo médico que o autor vem apresentando ganho ponderal progressivo e dificuldade do controle glicêmico apesar de estar seguindo as orientações nutricionais indicados e fazer uso do medicamento Metformina, razão pela qual lhe **foi indicado o uso de Liraglutida (Saxenda) na dose de 3mg/dia, aplicada com agulha novofine 4mm**.

A respeito da demanda do Autor, a Câmara de Resolução de Litígios de Saúde (CRLS), elaborou o Parecer Técnico CRLS Nº 106029/2024, esclarecendo que **o medicamento pleiteado pelo autor é registrado na ANVISA, sendo indicado para o quadro clínico que o acomete. No entanto, esclarece que o mesmo não se encontra padronizado em nenhuma lista de dispensação de medicamentos do Componente Básico, Estratégico ou Especializado, no âmbito do SUS no município ou do Estado do Rio de Janeiro**. Por fim, afirmou que não existem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento da condição clínica.

Segundo o orçamento apresentado pela Defensoria Pública, o custo anual estimado do medicamento é de R\$ 9.502,61.

No processo de origem foi anexado parecer do Nat Jus que teceu as seguintes considerações a respeito da demanda (Evento 28):

"DO QUADRO CLÍNICO

A obesidade infantil é resultado de uma série complexa de fatores genéticos, comportamentais, que atuam em vários contextos: familiar, escolar, social. Fatores que podem ocorrer ainda na gestação podem influenciar, como a nutrição inadequada da mãe e o excesso de peso. Também pode envolver um aleitamento materno de curta duração e introdução de alimentos de forma inadequada. Crianças com obesidade correm riscos de desenvolverem doenças nas articulações e nos ossos, diabetes e doenças cardíacas. Para evitar esses riscos, é essencial que a introdução alimentar seja feita no período correto (a partir dos 6 meses, após o período de aleitamento materno exclusivo) e com os alimentos balanceados. Se esse período não tiver o cuidado e atenção necessários, as crianças ficam expostas cada vez mais cedo aos alimentos ultraprocessados e industrializados.

A obesidade é uma condição crônica multifatorial que engloba diferentes dimensões: biológica, social, cultural, comportamental, de saúde pública e política. O desenvolvimento da obesidade decorre de interações entre o perfil genético de maior risco, fatores sociais e ambientais, por exemplo, inatividade física, ingesta calórica excessiva, ambiente intrauterino, uso de medicamentos obesogênicos e status socioeconômico. Sono insuficiente, disruptores endócrinos e microbiota intestinal também podem estar associados à gênese da obesidade. Mudanças ambientais e sociais resultaram na alteração dos padrões alimentares e de atividade física. Apesar da existência de políticas públicas para esses dois fatores de proteção, a constante promoção/incentivo ao consumo de alimentos e bebidas ultraprocessados (calorias líquidas – refrigerantes e sucos de frutas adoçados –, fast foods etc.) prejudicam a prevenção e o controle da obesidade. O acesso restrito da população a programas públicos de promoção de atividade física é também outro fator que dificulta o controle da obesidade². Recomenda-se o índice de massa corporal (IMC) para a medida da obesidade em nível populacional e na prática clínica. O IMC é estimado pela relação entre a massa corporal e a estatura, expresso em kg/m². Assim, a obesidade é definida como um IMC igual ou superior a 30 kg/m², sendo subdividida em termos de severidade em: IMC entre 30-34,9 – obesidade I, IMC entre 35-39,9 – obesidade II e IMC igual ou superior a 40 – obesidade III.

O Diabetes Mellitus (DM) refere-se a um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresenta em comum a hiperglicemia, a qual é o resultado de defeitos na ação da insulina, na secreção dela ou em ambas. Caracterizada pela deficiência de secreção da insulina e/ou sua incapacidade de exercer adequadamente seus efeitos. Alterações nos metabolismos lipídico e proteico são também frequentemente observados. A classificação atual do DM baseia-se na etiologia, e não no tipo de tratamento, portanto os termos DM insulino dependente e DM insulino independente devem ser eliminados dessa categoria classificatória. A classificação proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Associação Americana de Diabetes (ADA) inclui quatro classes clínicas: DM tipo 1 (DM1), DM tipo 2 (DM2), outros tipos específicos de DM e DM gestacional.

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é a forma mais comum de diabetes e caracteriza-se por defeitos na ação e secreção da insulina. Em geral, ambos os defeitos estão presentes quando a hiperglicemia se manifesta, porém, pode haver predomínio de um deles. A maioria dos pacientes com essa forma de DM apresenta sobrepeso ou obesidade, e cetoacidose raramente se desenvolve de modo espontâneo, ocorrendo apenas quando se associa a outras condições, como infecções. O DM2 pode ocorrer em qualquer idade, mas é geralmente diagnosticado após os 40 anos. Os pacientes não dependem de insulina exógena para sobreviver, porém podem necessitar de tratamento com insulina para obter controle metabólico adequado.

DO PLEITO

A Liraglutida é um agonista do receptor do Peptídeo Glucagon símile 1 humano (GLP-1) acilado, com 97% de homologia na sequência de aminoácidos ao GLP-1 humano endógeno. Em adolescentes (≥ 12 anos) pode ser utilizado em associação a nutrição saudável e atividade física para controle de peso em adolescentes a partir de 12 anos com: peso corporal acima de 60kg e obesidade (IMC correspondendo a ≥ 30 kg/m² para adultos por pontos de corte internacionais).

As agulhas são descartáveis (de uso único), atóxicas, aprotêicas e siliconizadas. Possuem corpos com paredes finas em aço inox. O bisel de cada agulha é trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação. Tem fixação perfeita ao canhão confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento. Em geral, são utilizadas para aspiração e aplicação de medicações a serem administradas via intramuscular e/ou via subcutânea, tanto em adultos como em crianças.

III - CONCLUSÃO.

Trata-se de autor, 12 anos, com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, obesidade grave (IMC: 34,2 Kg/m²), esteatose hepática, transtorno do espectro autista e outros transtornos psiquiátricos, além de déficit intelectual, com solicitação de uso de liraglutida 6mg/mL (Saxenda®) e ao insumo agulha 4mm (NovoFine®).

Informa-se que o medicamento Liraglutida 6mg/mL (Saxenda®) está indicado em bula para o manejo do quadro clínico apresentado pelo autor - obesidade, conforme relato médico.

No que tange à disponibilização pelo SUS do medicamento pleiteado insta mencionar que Liraglutida 6mg/mL não integra nenhuma lista oficial de medicamentos (Componente Básico, Estratégico e Especializado) dispensados pelo SUS, no âmbito do Município e do Estado do Rio de Janeiro. Logo, não cabe seu fornecimento a nenhuma das esferas de gestão do SUS.

Tendo em vista que, o Autor fará uso da liraglutida 6mg/mL (Saxenda®), o insumo pleiteado agulha 4mm (NovoFine®) será necessário para a aplicação da liraglutida. No entanto, o referido insumo não está padronizado para dispensação pelo SUS, no âmbito do município e do Estado do Rio de Janeiro.

Conforme observado em consulta ao sítio eletrônico da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) o medicamento Liraglutida foi analisado para o tratamento de pacientes com obesidade e IMC acima de 35kg/m², pré-diabetes e alto risco de doença cardiovascular, com a decisão final de não incorporar a tecnologia em questão no SUS.

A recomendação teve por fundamento a evidência de que a tecnologia não é custoefetiva e o seu elevado impacto orçamentário. Além disso, foram pontuadas a necessidade de se garantir, de forma efetiva, a oferta de medidas não medicamentosas, como modificação intensiva do estilo de vida e suporte psicológico e que a empresa demandante não adotou medidas para reduzir o preço do medicamento.

Posteriormente o medicamento Liraglutida esteve em análise pela da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde (CONITEC-MS)⁸ para o tratamento de pacientes com diabetes mellitus tipo 2, associada a doenças cardiovasculares, TFG <45, em uso de hipoglicemiantes e com indicação de intensificação do tratamento, porém o processo foi encerrado a pedido do demandante.

Salienta-se que foi publicado pelo Ministério da Saúde, a Portaria SCTIE/MS Nº 53, de 11 de novembro de 2020, a qual aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Sobrepeso e Obesidade em Adultos⁹. Sendo os critérios de inclusão Adultos (idade igual ou superior a 18 anos) com diagnóstico de sobrepeso ou obesidade (IMC igual ou superior a 25 kg/m²) com ou sem comorbidades que buscam atendimento no SUS¹⁰. Cabe ressaltar que, não foram previstos medicamentos para o tratamento da obesidade no referido PCDT.

Entretanto, considerando o caso em tela (autor com 12 anos), informa-se que no momento não há publicado pelo Ministério da Saúde Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Obesidade em crianças e adolescentes, e, portanto, não há lista oficial e específica de medicamentos que possam ser implementados nestas circunstâncias.

De acordo com Ministério da Saúde, a obesidade infantil está associada a maior chance de morte prematura, manutenção da obesidade e incapacidade na idade adulta. Crianças com obesidade têm 75% mais chances de se tornarem adolescentes obesos e 89% dos adolescentes obesos podem se tornar adultos obesos. Além de aumentar os riscos futuros, crianças e adolescentes com obesidade podem apresentar dificuldades respiratórias, aumento do risco de fraturas e outros agravos osteoarticulares, marcadores precoces de doenças cardiovasculares e efeitos psicológicos, como baixa autoestima, isolamento social e transtornos alimentares, entre outros. Além disso, já são comprovados outros impactos do excesso de peso na infância, como o comprometimento do rendimento escolar, que poderá implicar em maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho na vida adulta. Para a prevenção e o cuidado da obesidade, além do apoio aos indivíduos por meio de abordagens educativas/comportamentais, é fundamental a adoção de

políticas intersetoriais e medidas para reverter a natureza obesogênica dos locais onde as crianças, os adolescentes e suas famílias vivem. A obesidade infantil não deve ser vista como resultado de escolhas voluntárias de estilo de vida, especialmente por parte da criança. Dado que a obesidade infantil é influenciada por fatores biológicos e contextuais, são necessárias, a fim de apoiar os esforços das famílias para mudar comportamentos, ações governamentais e políticas públicas que visem à promoção da saúde, à implementação de medidas de prevenção do ganho de peso excessivo, ao diagnóstico precoce e ao cuidado adequado à criança, ao adolescente e às gestantes, bem como, ao estabelecimento de políticas intersetoriais e outras que promovam ambientes saudáveis. Pais, famílias, cuidadores e educadores também desempenham um papel fundamental no incentivo a comportamentos saudáveis.

Os pleitos possuem registro ativo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

No que concerne ao valor do medicamento pleiteado, no Brasil para um medicamento ser comercializado no país é preciso obter o registro sanitário na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a autorização de preço máximo pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).

De acordo com publicação da CMED14, o Preço Fábrica (PF) deve ser utilizado como referência quando a aquisição dos medicamentos não for determinada por ordem judicial e os medicamentos não se encontrarem relacionados no rol anexo ao Comunicado nº 6, de 2013, que regulamenta o artigo 4º da Resolução nº 3 de 2011, e o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) é utilizado como referência quando a compra for motivada por ordem judicial, e sempre que a aquisição contemplar medicamentos relacionados no rol anexo ao Comunicado nº 6, de 2013.

Assim, considerando a regulamentação vigente, em consulta a Tabela de Preços CMED, a Liraglutida 6mg/mL (Saxenda®) solução injetável com 1 cartucho 3mL possui o menor preço de fábrica consultado, correspondente a R\$ 270,93 e o menor preço de venda ao governo consultado, correspondente a R\$ 212,60; para o ICMS 20%."

A tutela foi deferida pela Juíza Tebelar durante as férias regulamentares da Relatora.

Apresentadas contrarrazões, vieram conclusos.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A medida requerida impõe a presença de requisitos atinentes a probabilidade do direito e ao perigo de dano. Ainda, o mesmo art 300 do CPC que a prevê também consigna que não será deferida em caso de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, no que se convencionou chamar de *periculum in mora inverso*:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

*§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de **irreversibilidade dos efeitos da decisão**.*

Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, que a obrigação da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária, de maneira que qualquer um dos referidos entes federativos pode figurar no polo passivo de demanda em que se objetiva assegurar o fornecimento ou custeio de medicamentos, ou tratamento médico. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(STF, Pleno, RE 855178 RG/PE, Relator Ministro LUIZ FUX, publicado em 16/03/2015).

Além disso, o entendimento quanto à legitimidade da União e, *mutatis mutandis*, também dos demais entes federados encontra-se, inclusive, sedimentado no Enunciado nº 43 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais desta Seção Judiciária do Rio de Janeiro, *in verbis*:

Enunciado 43: "A União é parte legítima nas demandas que visem assegurar o direito às prestações do Sistema Único de Saúde - SUS".

A descentralização administrativa dos serviços e recursos financeiros tem por fim tão somente o de melhorar a qualidade e o acesso à saúde, e não pode se prestar para afastar a responsabilidade de quaisquer dos entes. Pelo contrário, reforça a responsabilidade solidária, pois indica o trabalho conjunto para perseguir o fim constitucional.

O exame da questão passa pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, na STA em AgRg 175, onde aquele explicou que o Sistema Único de Saúde filiou-se à corrente da “Medicina com base em evidências”, de modo que **um medicamento ou tratamento em desconformidade com o Protocolo deve ser visto com cautela**, pois tende a contrariar consenso científico vigente. Mais do que isso: a gestão do SUS, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso universal e igualitário às ações de saúde, só se torna viável mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos (naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível. **Obrigar a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS**, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela da população mais necessitada.

Dessa forma, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida, **sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente**.

Com isso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que **o deferimento pelo Judiciário de medicamento extraordinário fora do âmbito do SUS, deve ficar restrito a hipóteses de rara e especial excepcionalidade**:

(a) quando a enfermidade do paciente não for tratada pelo SUS, ou;

(b) quando o tratamento/medicamento disponibilizado pelo SUS não tiver eficácia comprovada no caso concreto.

Caso não se inclua nestas hipóteses, **pelo fato de o SUS disponibilizar gratuitamente outros medicamentos para o tratamento da enfermidade**, não há que se falar em deferimento pelo Judiciário, sob pena de prejudicar, conforme já explicitado, o acesso universal e isonômico à saúde. E isto porque a opção pelo medicamento listado leva em consideração outros fatores: o **custo, a eficácia comprovada e a incidência sobre a patologia tratada, de modo a beneficiar a maioria da população**. Assim, a Administração Pública adota critérios plausíveis quando incorpora um medicamento à listagem daqueles que serão gratuitamente distribuídos, sendo inviável ignorá-los a fim de satisfazer a demanda de uma pessoa isoladamente.

Por tal razão, não cabe ao Judiciário ingerência sobre prioridades estabelecidas pelo Estado, que envolvam políticas públicas para garantir o regular atendimento e fornecimento de medicação na rede de saúde, sob pena de, por via transversa, criar situação de inaceitável desigualdade em relação aos demais usuários do SUS. O posicionamento acima é compartilhado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

*CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO ESPECÍFICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. União, Estados e Municípios, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são responsáveis solidários pelo fornecimento de medicamentos. **Não faz jus ao fornecimento de medicamentos pelo Poder Público o paciente que não se desincumbe de comprovar a real necessidade dos mesmos e a impossibilidade de substituí-los por outros disponibilizados pelo SUS.** Inversão da sucumbência, que é fixada na esteira dos precedentes da Turma. Prequestionamento estabelecido pelas razões de decidir. Apelações e remessa oficial providas. (apelação nº 0006160-45.2008.404.7200)*

Conclui-se, portanto, que é necessário demonstrar que **o tratamento fornecido pelo SUS não é adequado para controle da enfermidade da parte requerente para que, então, possa se fugir ao padrão e deferir terapia diversa, não havendo margem para escolha de tratamento que mais lhe aprouver**, desconsiderando as terapias já ofertadas pela Administração Pública, a partir da mera discricionariedade médica, ainda que o profissional esteja vinculado ao SUS.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese, em sede de representativo de controvérsia (tema 106), no sentido de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença **cumulativa** dos seguintes requisitos:

(a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(c) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.

De outro giro, é dizer: o Superior Tribunal de Justiça ratificou os requisitos já fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no que tange à prova de ineficácia do tratamento dispensado pelo SUS, e incluiu 2 novos, quais seja, a hipossuficiência econômica do requerente e o registro do medicamento na ANVISA, afastando, assim, o fornecimento de fármacos cuja eficácia não tenha sido atestada por órgãos de controle.

A Anvisa aprovou o registro do medicamento Saxenda (liraglutida) para controle crônico de peso, em associação a uma dieta baixa em calorias e aumento de exercício físico. A **indicação de uso da formulação é para adultos** com Índice de Massa Corporal (IMC) de: - 30kg/m² ou maior (obeso) ou; - 27kg/m² ou maior (sobrepeso) na presença de, pelo menos, **uma comorbidade relacionada ao peso**, como disglycemia (pré-diabetes e diabetes mellitus tipo 2), hipertensão arterial, dislipidemia ou apneia obstrutiva do sono.

Sobre o caso em tela, o Nat Jus destacou que "**considerando o caso em tela (autor com 12 anos), informa-se que no momento não há publicado pelo Ministério da Saúde Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Obesidade em crianças e adolescentes, e, portanto, não há lista oficial e específica de medicamentos que possam ser implementados nestas circunstâncias**".

Portanto, não existem alternativas farmacológicas, ou seja, outros medicamentos, disponíveis no SUS para tratamento da obesidade do autor por ser ele menor; o PCDT envolve mudanças de hábitos físicos e alimentares e, em certas hipóteses, a cirurgia bariátrica, mas não o fornecimento de remédios.

Entrementes, não existe comprovação nos autos de que o autor esteja inserido em Serviço Especializado de Atenção à Obesidade, e que, portanto, tenha experimentado o tratamento com equipe multidisciplinar para obesidade (médicos, nutricionistas, psicólogos, entre outras especialidades) sem obter sucesso ou que tenha modificado o estilo de vida, com adoção de dieta hipocalórica e prática de exercícios físicos regulares sem melhoria de sua condição de saúde a justificar a busca da solução medicamentosa que, repita-se não é o protocolo adotado pelo SUS.

Neste caso, em que pese a ausência de protocolo para a obesidade do autor por ser ele adolescente, tanto os medicamentos existentes no SUS para tratar a doença quanto aquele por ele pretendido são voltados para adultos, sem que os disponíveis no SUS tenham sido comprovadamente testados no caso do autor.

Em consulta na CONITEC, constata-se que a recomendação preliminar do referido órgão, que baseia-se em **critérios de viabilidade econômica para o SUS e evidências científicas da eficácia do medicamento**, foi pela não incorporação, nos seguintes termos: "*Os membros do Comitê de Medicamentos, presentes na 117ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de março de 2023, deliberaram por unanimidade que a matéria fosse disponibilizada em consulta pública com recomendação preliminar desfavorável à incorporação de liraglutida 3mg para tratamento de pacientes com obesidade e IMC acima de 35kg/m², pré-diabetes e alto risco de doença cardiovascular no SUS. Para a recomendação, o comitê considerou que a tecnologia utilizada de forma isolada não é efetiva para o controle da obesidade como problema de saúde pública e que ela deveria estar associada a medidas de modificação no estilo de vida, tais como dieta hipocalórica, prática de exercícios físicos, tratamento psicológico, dentre outras. Somado a isso, o plenário considerou a necessidade de uma rede ou programa especializado para o acompanhamento dos pacientes, em conformidade com o observado nas recomendações de outras agências de ATS; assim como as possíveis dificuldades para esse acompanhamento no âmbito do SUS; a não custo-efetividade da tecnologia; seu elevado impacto orçamentário e a incerteza quanto a relevância clínica do desfecho de redução de 5% no peso corporal.*" (https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2023/20230511_relatorio_liraglutida_cp_17_2023.pdf)

Diante desse quadro, **deve-se privilegiar métodos que envolvam mudanças no estilo de vida em detrimento de uso de medicamentos**.

Acontece que, no presente caso, o Autor possui 12 anos de idade, com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, obesidade grave (IMC: 34,2 Kg/m²), esteatose hepática, transtorno do espectro autista e outros transtornos psiquiátricos.

Verifica-se no Laudo contido no Evento 01, Anexo 02, Folha 16, que embora o Autor esteja seguindo as orientações nutricionais indicadas e faça uso diário do medicamento "Metformina" em dose de 1000 mg, **o requerente apresenta ganho ponderal progressivo e dificuldade do controle glicêmico**, razão pela qual lhe foi indicado o uso de "Liraglutida (Saxenda)" na dose de 3mg/dia, aplicada com "agulha novofine 4mm".

Diante disso, em que pese a orientação do SUS ser no sentido de utilização de tratamentos contra obesidade que privilegiem a não utilização de medicamentos, **o atual quadro clínico do Autor requer urgência, sobretudo ante a tenra idade (12 anos) com as agravantes das demais doenças (esteatose hepática, transtorno do espectro autista e outros transtornos psiquiátricos.)**. A urgência ficou evidenciada no Formulário Médico contido nos autos do processo de origem que indica que a ausência do fornecimento do medicamento poderá ocasionar perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas, grave comprometimento do bem estar.

Nesse mesmo sentido, o médico assistente da CRLS relatou que "*o assistido faz uso de metformina e orientações nutricionais, mas vem apresentado ganho de peso ponderal e progressivo, **apresenta risco e acidente vascular cerebral**. No momento **pesando 130,7 Kg** e IMC 34,2".*

Assim, presente a urgência e os requisitos definidos no âmbito do REsp nº 1.657.156/RJ, **pois a médica assistente ressalta que o autor já faz uso de Meftormina para controle dos sintomas provocados pela diabetes, sem sucesso**. Deve-se, porém, dar parcial provimento aos Embargos da União de modo a que sejam fornecidos os insumos dentro dos limites orçamentários destacados pelo NAT em sua última manifestação ("*em consulta a Tabela de Preços CMED, a Liraglutida 6mg/mL (Saxenda®) solução injetável com 1 cartucho 3mL possui o menor preço de fábrica consultado, correspondente a R\$ 270,93 e o menor preço de venda ao governo consultado, correspondente a R\$ 212,60; para o ICMS 20%*").

Ante o exposto, **voto por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO da DPU e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO, de modo que a concessão da medida determinada na decisão do Evento 11 destes autos esteja condicionada aos limites orçamentários destacados pelo NAT (a Liraglutida 6mg/mL (Saxenda®) solução injetável com 1 cartucho 3mL possui o menor preço de venda ao governo de R\$ 212,60)**. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019)**. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.